TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
FORO DE SOROCABA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
RUA 28 DE OUTUBRO, Nº 691, SOROCABA - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	**1041216-24.2024.8.26.0602**
Classe - Assunto	**Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Fornecimento de medicamentos**
Requerente:	**Martha Jean Jefferson**
Requerido:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL NAKAD JUNIOR

Vistos.

Dispensa-se o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.

O processo comporta **julgamento antecipado**, conforme autoriza o **art. 355, I**, do Código de Processo Civil, haja vista ser desnecessária a produção de prova em audiência. Ademais, anoto que ao magistrado incumbe o poder-dever de julgar de forma antecipada a lide quando esteja convencido de que eventual dilação probatória é desnecessária ou procrastinatória.

Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

> "Nos termos da jurisprudência desta Corte, **cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento.**" (AgInt no AREsp 1787991/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

No mesmo diapasão:

> "**A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.**" (AgInt no AREsp 1720864/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021)

Ademais, como se sabe, o microssistema dos Juizados Especiais orienta-se por princípios, tais como a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade.

Nesse sentido, a presente sentença também deve ser informada por esses princípios, em especial, a simplicidade e a informalidade, a fim de que o jurisdicionado tenha de forma mais célere e ágil o seu provimento jurisdicional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.

Assim, cabe analisar de imediato se este juízo possui **competência material** para a apreciação do pedido contido na inicial.

No presente caso, verifico que a causa versa sobre uma das matérias constantes no **artigo 2º, da Lei 12.153/09, Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública**: causas cíveis de **interesse dos Estados e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos**.

Observo também que a causa **não versa sobre as ações e matérias vedadas** no microssistema do **Juizado Especial da Fazenda Pública**, previstas no § 1º, do artigo 2º, dessa Lei: mandado de segurança; ação popular; desapropriação, divisão e demarcação, improbidade administrativa, execuções fiscais e direitos ou interesses difusos e coletivos.

No mais, a causa não trata de bens imóveis dos Estados, Municípios, nem de suas autarquias e fundações públicas. Por fim, quanto à competência pela matéria, a causa não tem como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Sem prejuízo, o artigo 10 da Lei 12.153/09 permite expressamente a realização de **EXAME TÉCNICO NECESSÁRIO** à conciliação ou ao julgamento da causa, ou seja, **NÃO HÁ QUALQUER PROIBIÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA**:

> "A jurisprudência desta Corte entende que **a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.** Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011..." (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

Assim, este juízo é competente para a apreciação do pedido.

Há de atentar-se também a **limitação subjetiva** imposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei 12.153/09 restringe às **pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte, como autoras; como réus, restringe-se a participação, na Justiça Estadual, aos Estados e Municípios, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas.** No caso em deslinde, não qualquer participação que fuja da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem.

De início, afasto as preliminares suscitadas pela parte ré, pois elas se confundem com o mérito e com ele serão apreciadas.

No mérito, cuida-se de ação de obrigação de fazer, a fim de que o ente público demandado forneça os medicamentos descritos na inicial.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.

Como se sabe, o artigo 196 da Constituição da República estabelece que:

> "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

É de se ressaltar que o referido dispositivo legal não necessita de regulamentação, tendo densidade normativa suficiente para ser aplicado imediatamente, não se tratando de norma apenas programática. Nesse sentido, o entendimento proferido em decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. a) **Autoaplicabilidade do art. 196 da Constituição Federal. Postulado constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no art. 6º, caput, da Carta, com aplicação imediata, leia-se, § 1º, do art. 5º, da mesma Constituição, e não um direito meramente programático**. b) Princípio da Tripartição dos Poderes. Dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Da Proibição de Retrocesso. A despeito da alegação do Estado de que há violação ao poder discricionário da Administração Pública, em que pese não se possa desconsiderar a conveniência e oportunidade, de forma a relegar qualquer interferência judicial, pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, a violação de direitos fundamentais, sobretudo a uma existência digna, haja vista a inércia do Poder Executivo, legitima o controle judicial. c) Da Reserva do Possível. O princípio da reserva do possível não se aplica quando se está diante de direitos fundamentais, em que se busca preservar a dignidade da vida humana, consagrado na Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático e Social de Direito (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal). d) **Direito aos medicamentos. Em sendo dever do ente público a garantia da saúde física e mental dos indivíduos e, em restando comprovado nos autos a necessidade da parte requerente de fazer uso dos medicamentos descritos na inicial, imperiosa a procedência do pedido para que o ente público o custeie. Exegese que se faz do disposto nos artigos 196, 200 e 241, X, da Constituição Federal, e Lei nº 9.908/93.** (...) (Apelação Cível Nº 70052582152, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 04/02/2013)

A fim de conceder maior amplitude ao artigo supracitado, o legislador constituinte instituiu, por meio do artigo 198, II, da Constituição Federal, uma diretriz no sentido de promover o atendimento integral àqueles que dele necessitem. Segundo esse dispositivo:

> “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.

> (...)
> II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;"

Deste modo, é imperiosa a compreensão do termo "atendimento integral", o qual deve ser interpretado de modo expansivo. É dizer, cabe ao Estado promover as espécies de tratamentos e os medicamentos que serão fornecidos aos necessitados, devendo, sempre que possível, atender as demandas imprescindíveis à efetiva garantia do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana daquele afetado por determinada condição médica.

Por essa razão, aquele que não detiver recursos para obter, por seus próprios recursos, os cuidados necessários à sua saúde, merece especial proteção e amparo do Estado. Assim, para que qualquer dos entes federados seja condenado a fornecer determinados medicamentos ou promover o acesso a tratamentos de moléstias, necessário que o cidadão demonstre a efetiva necessidade do tratamento recomendado pelos especialistas. Em outras palavras, **cumpre ao pleiteante demonstrar que se encontra acometido de determinada moléstia que torne imprescindível o uso do medicamento que pretende obter.**

Saliento que não há de se cogitar eventual violação ao princípio da tripartição e independência de poderes, pois o que se pretende é fazer cumprir a lei, atribuição esta exclusiva do Poder Judiciário. Ademais, como existe lei ordenando o fornecimento do medicamento, o Poder Judiciário apenas determina que seja cumprida a lei.

Do mesmo modo, não se pode falar em ausência de previsão na lei orçamentária, pois à Administração não é dado o direito de escusar-se ao cumprimento de norma constitucional e legal pela simples alegação de ausência de previsão de gastos. Note-se que o legislador constituinte já elegeu a saúde e a educação como prioridades da Administração, estabelecendo percentuais mínimos de gastos nestas áreas. Deste modo, a mera alegação a respeito da Teoria da Reserva do Possível como forma sinônima de falta de recursos não é autossustentável, visto que é necessário que o Poder Público comprove tal situação por meio da denominada exaustão orçamentária. Nesse sentido, segue a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 45 em 29.04.2004:

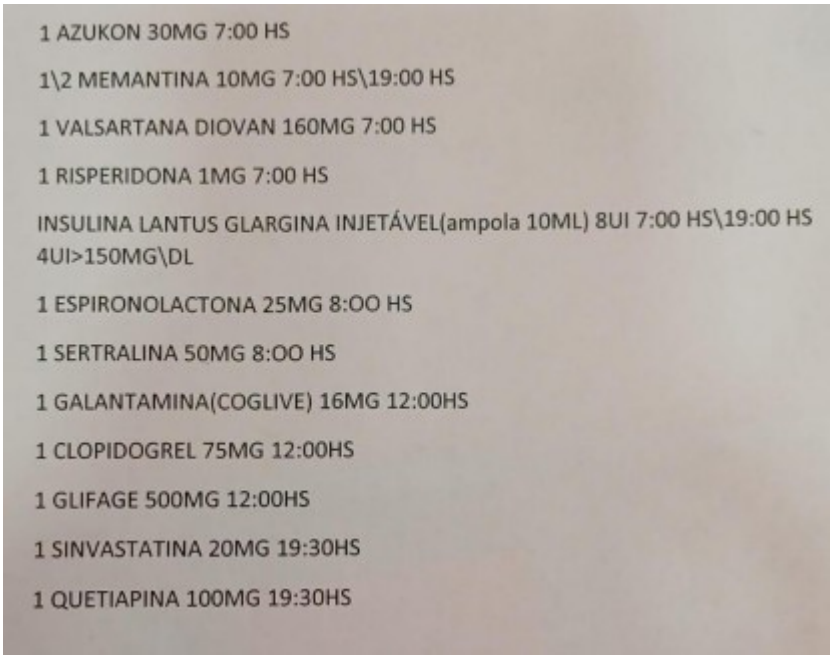
> "**A reserva do possível traduzida como insuficiência de recursos, também denominada reserva do financeiramente possível, portanto, tem aptidão de afastar a intervenção do Poder Judiciária na efetivação de direitos fundamentais apenas na hipótese de comprovação de ausência de recursos orçamentários suficientes para tanto.** Tal viés da teoria da reserva do possível é importante e deve ser entendido com o objetivo de vincular o direito à economia, no sentido de que as necessidades − mesmo aquelas relacionadas aos direitos sociais − são ilimitadas e os recursos são escassos. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais − além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização − depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.

> considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese − mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa − criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. **Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" − ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível − não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade (...)"** (STF, ADPF n. 45, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 29.04.04, g. n.).

Não obstante, em razão da massiva judicialização da saúde, o Supremo Tribunal Federal foi provocado e firmou importantes posicionamentos sobre a concessão judicial de medicamentos, objeto dos temas nº 6 e nº 1.234 de repercussão geral.

No caso, a autora requereu o fornecimento dos seguintes medicamentos:


1 AZUKON 30MG 7:00 HS

1\2 MEMANTINA 10MG 7:00 HS\19:00 HS

1 VALSARTANA DIOVAN 160MG 7:00 HS

1 RISPERIDONA 1MG 7:00 HS

INSULINA LANTUS GLARGINA INJETÁVEL(ampola 10ML) 8UI 7:00 HS\19:00 HS 4UI>150MG\DL

1 ESPIRONOLACTONA 25MG 8:OO HS

1 SERTRALINA 50MG 8:OO HS

1 GALANTAMINA(COGLIVE) 16MG 12:00HS

1 CLOPIDOGREL 75MG 12:00HS

1 GLIFAGE 500MG 12:00HS

1 SINVASTATINA 20MG 19:30HS

1 QUETIAPINA 100MG 19:30HS

No julgamento do RE 1.366.243/SC, paradigma do Tema 1234, o Plenário decidiu pela homologação do acordo apresentado pelo ministro Gilmar Mendes a partir das discussões entre União, estados e municípios, visando a facilitação da gestão e o acompanhamento dos pedidos de fornecimento de medicamentos, com a consequente fixação de diretrizes para a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
FORO DE SOROCABA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
RUA 28 DE OUTUBRO, Nº 691, SOROCABA - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

atuação do Judiciário.

A tese dividiu-se em 6 tópicos.

Segundo o documento apresentado às fls. 111/119, dos medicamentos requeridos, **apenas o Valsartana 160mg (Diovan) e a Insulina Glargina (Lantus) não estão contemplados na RENAME e não estão disponíveis em nenhuma instância do SUS.**

Em relação aos demais, por se tratar de pedido de **medicamentos incorporados,** devem ser aplicadas as orientações do item 6, segundo o qual:

> **VI – Medicamentos incorporados.**
>
> 6) Em relação aos **medicamentos incorporados**, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir **o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I,** inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
>
> 6.1) A(o) **magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo** (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.

O fluxo detalhado no Anexo I é o seguinte:

AUDIÊNCIA TEMA 1234 - 21 DE NOVEMBRO DE 2023
FLUXO DE INCORPORADOS - CEAF

CEAF Componente Especializado	FINANCIAMENTO	AQUISIÇÃO	PROGRAMAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO	DISPENSAÇÃO
GRUPO 1A	UNIÃO	UNIÃO	UNIÃO/ESTADO	UNIÃO/ESTADO	ESTADO*
GRUPO 1B	UNIÃO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO*
GRUPO 2	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO*
GRUPO 3	TRIPARTITE**	MUNICÍPIO***	MUNICÍPIO***	MUNICÍPIO***	MUNICÍPIO

*Há estados que repassam, via pactuação CIB, a atribuição de dispensação aos municípios. (Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, Título IV, Capítulo 2, Art. 67)
**Financiamento tripartite já pactuado na CIT, por meio de transferência fundo a fundo (FNS, FES e FMS).
***Em situações previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas, entre outros), com observação e que a distribuição para os municípios é de responsabilidade dos estados. Sob nenhuma hipótese envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Nota 1: No caso do Distrito Federal, este ente abarcará as competências dos Estados e Municípios.
Nota 2: No caso de fornecimento de medicamentos à população indígena, em quaisquer dos grupos acima, a responsabilidade é da União, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017.

No acórdão do recurso extraordinário, constou em relação à atuação da Administração Pública em relação aos **medicamentos incorporados (fls. 103/104 do acórdão):**

> "**Atuação da Administração Pública na íntegra do item 4.1**: as respostas administrativas poderão ser deferimento, indeferimento, devolução para Instrução e impossibilidade/inviabilidade de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.

> fornecimento, em regra. **No caso de indeferimento ou deferimento da autorização da dispensação, mas com óbices para dispensação, o ente público deverá justificar a causa/motivo**. Os Conselhos profissionais exercerão o controle ético da prescrição, em caso de medicamento que seja prescrito fora da política pública do SUS, analisando a reiteração da conduta do profissional prescritor, podendo exercer seu poder-dever em caso de desvio ético, em razão, v.g. de aquele "assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente" (art. 3º do Código de Ética Médica– Resolução CFM 2.217/2018– Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf. Acesso em: 19.6.2024)" - grifei.

No caso, embora incorporados, verifica-se que a autora **sequer comprovou a negativa administrativa,** não obstante tenha sido devidamente intimada para esse fim (fls. 59 e 79/81).

Como não foi demonstrado o indeferimento indevido, não cabe ao Poder Judiciário substituir a atuação da Administração Pública, razão pela qual tal pedido improcede.

Já em relação aos medicamentos **Valsartana 160mg (Diovan) e a Insulina Glargina (Lantus)**, no julgamento do RE 566.471/RN, paradigma do Tema 6 de Repercussão Geral, o STF delimitou os critérios para eventual concessão judicial de **medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS** (Rename e Remume).

Foi fixada a seguinte tese:

> "1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
>
> 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, **desde que preenchidos**, **cumulativamente**, os seguintes **requisitos**, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
>
> > (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral;
> >
> > (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.

> (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
>
> (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
>
> (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
>
> (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
>
> 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
>
> > (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;
> >
> > (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e
> >
> > (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”
> >
> > (Informativo 1152; Tema 6 RG; RE 566.471/RN - julgamento virtual finalizado em 20.09.2024)

A própria corte determinou que tais diretrizes sejam transformadas em enunciado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação:

> A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.

> Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Portanto, verifica-se que pelo item 1 da tese transcrita que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS **impede**, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo, **salvo** se o interessado comprovar o preenchimento de todos os requisitos do item 2.

Por essas razões, a parte autora foi intimada para esclarecer e comprovar documentalmente se o(s) medicamento(s) solicitado(s) é(são) incorporado(s) às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde − SUS (Rename e Remume), bem como, em caso negativo, comprovar, também, o **preenchimento de todos os requisitos do item 2** da tese do Supremo Tribunal Federal acima mencionada.

Apesar disso, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos cumulativos determinados, **especialmente**, a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011 e a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.

Ante ao exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO,** com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Dispensado o reexame obrigatório (art. 11, da Lei 12.153/09).

Por fim, resta a advertência às partes de que a decisão analisou e julgou todos os pedidos postulados e a oposição de embargos de declaração para reexame de matéria (ainda que nomeado sob forma diversa) possui natureza protelatória, cabível a aplicação de multa de até 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nesta instância, por expressa regra contida no art. 55, “caput”, primeira parte, da Lei nº. 9.099/95, não há condenação nas verbas de sucumbência.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos, observadas e cumpridas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sorocaba, 05 de maio de 2025.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JAMIL NAKAD JUNIOR, liberado nos autos em 06/05/2025 às 10:49 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041216-24.2024.8.26.0602 e código ojrkkKMe.